

06 - 06- Greffe de Cornée - Pr. MOUTAOUAKIL

Bonjour, un autre chapitre qui m'est très cher, ici à Marrakech, c'est le chapitre de la greffe de corne et la banque des yeux et c'est un chapitre essentiellement que j'enseigne dans le but de promouvoir le dons d'organes et en particulier le don des tissus, à savoir la membrane amniotique ou bien les cornes. Nous allons donc aborder ce chapitre pour connaître les indications de la greffe de corne, connaître le pronostic et les différentes complications de la greffe de corne, participer à la sensibilisation, c'est le point le plus important, à l'importance de dons d'organes. Nous allons adopter le plan suivant, introduction des rappels historiques, les indications techniques, pronostic, complications et exposer donc notre expérience.

La greffe de corne est le remplacement d'une corne malade par une corne saine, prévenant d'un veneur décédé. Plusieurs techniques qui ont eu une évolution considérable, qu'on ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but de ce cours. Le taux de succès en termes de survie de greffons à 5 ans est élevé, variant de 60 à 90%.

Et on dit que la greffe de corne est la greffe la plus réussie dans le monde. L'importation est la principale source de greffons actuellement, pourquoi ? Parce que le pan de l'organe est encore au stade embryonnaire dans notre pays. Les greffons locaux sont très insuffisants.

La législation existe actuellement, c'est une législation qui a été promulguée en 1998, c'est la loi 1698 qui régit le prélèvement, la greffe, le consentement et tous les aspects légaux de la greffe au Maroc. Alors, rappel, la corne, comme vous le savez, c'est la calotte transparente au niveau de l'œil à l'extrémité antérieure, elle est constituée de cinq couches. Cette corne transparente, elle a la particularité anatomique de ne pas avoir de vascularisation et ceci peut-être est la clé de la réussite de la greffe de corne parce qu'elle n'est pas vascularisée, il n'y a pas de vaisseau.

Donc, il explique tous les phénomènes qu'on va voir. Il y a différents types de greffes, il y a la transfection, lorsqu'on enlève toute l'épaisseur de la corne et on remet une autre corne. Il y a les greffes lamellaires qu'on peut utiliser comme greffe antérieure et il y a les greffes endothéliales, ce sont les principaux greffes de corne actuellement utilisés.

Les particularités de la greffe de corne, la corne est un site privilégié pour la greffe, il n'y a pas de vaisseau sanguin ni lymphatique, peu de cellules, donc le conflit immunologique est très réduit, pratiquement inexistant lorsque la greffe, lorsque les indications ont été bien respectées. Alors sur le plan historique, première greffe qui a été faite dans le monde, c'est en 1905. La banque des yeux du Maroc, elle date de 1950, elle est reconnue d'utilité publique.

Une quarantaine de cas jusqu'aux années 90 et il y a eu un long silence jusqu'à l'apparition de la loi 1698 où il y a eu le début de la greffe de corne, en particulier le ptachirzé 2003 grâce à l'importation des Etats-Unis et en août 2009, on a eu le privilège d'avoir un don de l'agence de bio-médecine, on a greffé des corneilles. On a commencé par une convention avec les Etats-

Unis en 2010 et nous avons aussi réalisé la première banque des yeux réelle, existante, au Maroc, qui est la banque des yeux de Marrakech et qui existe actuellement depuis 2014. En 2012, il y a eu le premier prélèvement local ici à Marrakech.

La greffe de corneille au Maroc se compare avec qui ? Voilà les chiffres, les statistiques en Europe, dans certains pays qui sont un petit peu semblables à nous, donc sincèrement la greffe de corneille reste au-dessous des attentes au niveau de notre pays. Alors sur le plan épidémiologique, les besoins en greffe, il n'y a que la seule étude qui a été réalisée en 1992 et qui prévoyait une cécité corneille à 10,4%, 2 000 cécités corneilles par an, unies aux bilatérales, l'enfant et les adultes, donc c'est une étude qui a été faite et qui est actuellement complètement dépassée, on n'a pas eu d'étude après pour évaluer la prévalence de la cécité corneille dans la population générale. Il faut savoir que les indications majeures sont essentiellement représentées par deux indications.

Le kératocone au sein de greffe et la kératopathie bulleuse soit secondaire à une chirurgie ou une kératopathie bulleuse, donc qui peut se voir dans le cadre d'un certain nombre de maladies de la corneille. Ensuite, nous avons l'herpès, mais c'est une mauvaise indication de la greffe de corneille, nous avons aussi les traumatismes et les dystrophies de corneille, nous avons aussi les brûlures de corneille, mais ce sont de mauvaises indications parce qu'en général, la corneille est néovascularisée, donc le risque de rejet est très très important, les kératites infectieuses aussi, le tracon c'est une mauvaise indication des greffes de corneille parce qu'il survient sur des yeux qui sont avec une sécheresse oculaire, avec une néovascularisation, avec énormément de problèmes. Alors la technique chirurgicale est simple et codifiée, elle consiste à prélever par prépanation circulaire une rondelle de la corneille par logique de receveur, un diamètre variant selon l'indication de certains millimètres, que l'on remplace par une rondelle de diamètre éventif de corneille saine, revenant d'un doigt.

Cette rondelle corneille est suturée à la corneille de receveur par un surgé ou par des points séparés de fils non résorbables. Il est possible au cours de cette greffe de combiner d'autres gestes chirurgicaux, c'est nécessaire extraction du cristallin avec mise en place d'un implant intra-oculaire ou le traitement chirurgical d'un glaucome. Le traitement post-opératoire comporte une corticothérapie, une antibiothérapie locale et des agents bouillants.

Le surgé ou les points sont laissés en place, on verra. La technique chirurgicale par vidéo, je vais vous l'exposer au cours de notre discussion. En général, le pronostic, on a de bons résultats anatomiques qui fonctionnent, 2 tiers des cas selon la littérature, bonnes récupérations visuelles à long terme.

La microscopie spiculaire, à gauche, densité cellulaire satisfaisante à 2500 après greffe endothéliale, à droite, faible densité cellulaire à 729 un an après une greffe endothéliale, en sachant qu'après une greffe, il y a toujours, toujours une déperdition cellulaire. Le rejet, il existe, on a un œil rouge au stade pré-gosse et les régressifs sous traitement, au stade tardif, parfois

l'échec, d'où l'intérêt de consulter en urgence devant un œil rouge et ou douleur et ou baignements qui utilisent les chisins greffés de corne. Parfois, on a des retards d'épithélialisation, les hypertensions oculaires, les cataractes, les récurrences de maladies causales, en particulier l'herpès ou le kératocône, l'astigmatisme post-opératoire qu'il faut gérer.

Nous avons réalisé, dans notre service, 174 greffes de corne, le rejet 9% des cas, le QT visuel était supérieur à 7 dixièmes, donc 75% de cas. Seulement 32 greffants sont prélevés localement, d'où la nécessité de sensibilisation et promouvoir le don d'organes. Je vous montre un exemple d'une patiente greffée chez nous, c'est elle que je vais vous montrer sur la vidéo.

Regardez l'opacité au niveau de l'œil droit et au niveau de l'œil gauche, regardez sous l'opacité bilatérale, cette patiente, elle comptait les doigts, c'est-à-dire qu'elle était en Sicile, et regardez le lendemain d'une greffe de corne, ça vaut la peine de donner les organes pour donc promouvoir cette pratique qui reste une pratique très intéressante sur le plan de la récupération visuelle. Un autre patient de notre série, regardez, c'est un choroïdite très évolué à l'âge de 49 ans, donc avec une capacité très importante, ectasie, et donc regardez, à J1 post-opératoire, donc l'œil est encore inflammé, on voit donc l'évolution. Hanane aussi, regardez, c'est une dystrophie, c'est une corne qui est nuageuse, il ne voyait rien, ça c'est l'œil droit de Hanane et ça c'est l'œil gauche de Hanane, et donc regardez, après une greffe, c'est une dystrophie, et regardez, après une greffe, qu'est-ce que vous avez ? Un autre cas de choroïdite avec opacité post-opératoire.

Donc, le don d'organes, le don d'organes est quelque chose de très très important. En novembre 2010, début de la construction de la banque des yeux, on dit donne à un homme un poisson, il va manger un jour, après lui a pêché, il mangera toute sa vie, donc nous avons commencé notre première banque des yeux qui existe au niveau du CHU, voici la banque des yeux, nous avons réalisé notre premier prélèvement en septembre 2011, nous avons fait plusieurs spots publicitaires, comme vous voyez ici, avec des explications sur la greffe de Corneille, la loi 1698 parle de la greffe de Corneille sur dons décédés, après consentement et inscription au registre, la gratuité, l'anonymat, on fait les sérologies et on respecte donc les contre-indications. En conclusion, nous pouvons dire que le rêve a été réalisé, mais il existe beaucoup de défis depuis, et le chemin est lent pour inverser cette tendance, parce qu'on continue à importer les cornes depuis les Etats-Unis, les prélèvements locaux restent très rares, comme vous le voyez ici.

Comment on peut réaliser ce défi ? Grâce à la sensibilisation du public, grâce à la facilité de la procédure de donation, grâce à l'utilisation donc de la religion et expliquer aux patients que la religion ne contre-indique pas le prélèvement, il faut absolument développer le prélèvement local. Donc je termine cette communication, ce secours, par vous expliquer ce tableau qui a été peint par un homme qui a visité la Banque des yeux et qui a exprimé sur ce tableau qui existe au niveau de la Banque des yeux, un œil, en terre et sous terre, à partir duquel il y a un arbre qui se dégage et qui va donner la vue à quelqu'un au-dessus de la terre. Je n'ai pas trouvé de plus représentant de cette action que ce tableau.

Je vous remercie.